

19-7-26

ניהול חדירה לא מכוונת לדורה

Unintentional Dural Puncture (UDP)

מתמחים יקרים

לעתים קורא מהלך לא תקין בניסיון לבצע אפידורל - חדירה לא מתוכננת אל תוך הדורה.

כיצד לפעול?

במשמרת יום – לעצור ולקרוא לרופאה בכיר

במשמרת ערב / לילה

שינוך כאב:

בכל מקרה של חדירה לא מכוונת לדורה יש לעצור את הפעולה ולהזעיק את הרופא האחראי (רופא בכיר ביום / תורן 1 בערב ובלילה).

בכל מקרה של UDP יש לעדכן את תורן 1.

אופציות:

לבצע שוב ניסיון אפידורל

גשר זמני עם פנטניל PCA עד החלטה על המשך שינוך הכאב

הכנסת קטטר ספינלי

לשיקול התורנים להכניס קטטר ספינלי בנסיבות כגון:

1. אפידורל שהיה קשה לביצוע / אחרי מס נסיונות
2. סבירות גבוהה לקיסרי מקרוב
3. לידה מאוד מתקדמת
4. קושי צפוי בביצוע ניסיון ניראקסיאלי נוסף (למשל קושי בשמירת תנוחה)
5. זיהוי מאוחר של קטטר תוך-תקאלי לאחר מתן תרופות שניתנו בהנחה שמדובר בקטטר אפידורלי.

מנת התחלה מומלצת:

bupivacaine 1.5-2.5 mg + פנטניל 10-20 מיקרוגרם

לאחר שינוך כאב יש לשקול המשך הדרך - להשאיר קטטר בחלל ספינלי או להחליף לאפידורל.

בטיחות:

אם הוחלט להשאיר קטטר תוך-תקאלי:

- לסמן באופן ברור INTRATHECAL/SPINAL
- לוודא שכל אנשי הצוות מודעים לכך – גם מיילדות, רופאי נשים, צוות הרדמה
- למסור דיווח מפורש בכל החלפת משמרת
- אין לתת מינונים אפידורליים דרך הקטטר

חשוב לתעד מהלך בתיק, ולסמן באופן ברור קטטר ספינלי, לעדכן תורן 1 נשים וגם תורן מרדים

תיעוד ומעקב:

יש לתעד את נעשה, הטיפול והשיחה עם היולדת בקמיליון

יש להכניס מדבקה בספר מעקב (שנמצא בחדר תורנים)

יש לדווח לצוות בוקר בהעברה ב 0800 - לד"ר אפטקמן, פרופ' וייניגר, ד"ר גרינברגר, ד"ר אביטל

Management of Unintentional Dural Puncture (UDP)

